



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : منال جمعة ابراهيم عواد
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : المعادي
رقم البطاقة : 27610052103007 رقم التليفون : 01123484842
العنوان : المعادي حلوان
العمر (تاريخ الميلاد) : 05-10-1976 المهنة : بدون عمل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي تراستوزوماب بعد الجراحة تحت
الجلد [14112]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منال جمعة ابراهيم عراد National ID: 27610052103007	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Trastuzumab Subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جوستاف
روستاف
مستشفى
مصر

ما
ق
9-0

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاستشارة
مصر

09/20/2026

MDT FORM

Name:	Manal Gomaa Ibrahim Awaad	MRN:	5683
Age:	50 Y	ID:	27610052103007
Menopausal Sta	POST	Phone:	01123484842
NRS SCORE:		Marital Status:	MARRIED
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	POST RT CBS +ALND 3YS AGO	Reason Of MDT:	POST OP

Clinical Data:

BX: MIXED METAPLASTIC SQUAMOUS CARCINOMA AND INVAS

ER: 0/8

PR: 0/8

HER2: 3+

KI67:

R

L

Sonomammography:

POST RT SM (COMPLETION) WITHOUT NODES

FREE MARGINS

FREE SKIN

DIFFERENT PATHOLOGY SO IHC REQ

T2 NX MX

Mets Workup:

RT BREAST CANCER (T3 N1 MO) RT WLE + ALND IN 2/2024 (POST NACT) FOR

IDC ER 0/8 PR 3/8 HER +3 AND RECEIVED PORT POST OP AND TAMOXIFEN 5

YS.(FREE MARGINS LNS0/13)

LT WLE FOR FIBROADENOMA AT SAME OP

History:

Recommendations:

NEW IHC REQUESTED (RECEIVED)

MDT Outcome & Plan

FOR ADJ AC*4 then weekly taxol 12 weeks with herceptin 1 year

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د حنان عزت					

٥٠٦٥٠٦٦٢٦

جمهورية مصر العربية
بكالوريوس محمد بن المشيخي

محل
جمعة ابراهيم عواد
١٠ ش قنص عطيه - حلي قريه
المعادي - القاهرة

٢٧٦١٠٠٥٢١٠٣٠٠٧

J28336183

DMS
قوله
عن
عن

٢٠٢٣/٥ ٢٧٦١٠٠٥٢١٠٣٠٠٧
حاصلة على ليسانس ادب
التي مسلمة
نادر محمود عبد الوهاب عبد المجيد
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٥/٢٩

٢٠٢٣/٥

Patient Name	منال جمعه ابراهيم	Case No.	344070
Sex/Age	Female 49 Y	Patient No.	25172
Registered Date	25/7/2026 04:24:05 PM	Referred By Dr.	Surgery
Validation Date	07/9/2026 11:42:40 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	07/9/2026 12:15:32 PM	Pathology No.	2339/26

Pathology Report (Corrected Report)

Clinical Data: Right breast cancer (Up-front).

Nature of specimen: Right simple mastectomy.

Gross Examination:

- * Right simple mastectomy specimen measured 10x7.0x6.0 cm, with covering skin ellipse 10x5.0x5.0 cm. Nipple & areola looked unremarkable grossly.
- * Serialling showed single ill-defined firm grey, white mass measured 3.0x3.0x2.5 cm, located 1 cm from the deep margin.

*** Block designation "8 Blocks":**

1,2- Mass., 3- Mass& Deep margin., 4- Superior margin., 5- Inferior margin., 6- Lateral Margin., 7- Medial Margin., 8-Skin. - Gross was done by; Dr. Aya Ezzat.

Microscopic examination:

- **Histological type:** Mixed metaplastic squamous carcinoma & Invasive breast carcinoma, NST. (80%).
- **Tumor size:** 3.0x3.0 cm.
- **Ductal carcinoma in situ:** 20% High grade DCIS (Clinging pattern with comedo type necrosis).
- **Lympho-vascular emboli:** Absent.
- **Microcalcification:** Absent.
- **Skin:** Free, intact epidermis.
- **Resection Margins:** Free margins.
- **Other pathological findings:** Lactiferous ducts are involved by squamous carcinoma in situ changes, supporting primary breast origin.

Diagnosis:

Right breast mass (Up-front), Right simple mastectomy:

- Mixed metaplastic squamous carcinoma & Invasive breast carcinoma, NST. (80%).
- 20% High grade ductal carcinoma in situ (Clinging pattern with comedo type necrosis).
- Skin: Free, intact epidermis.



PATIENT NAME: Manal Gomaa Ibrahim Awad

GENDER: Female

DATE : 29-Apr-2026 10:24 AM

PATIENT ID: 2019073644

AGE: 49 y

ORDER: 3849740,3849931

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY

INDICATION:

- history of right CBS of pathologically proven IDC.
- Left UOQ lumpectomy of benign lesion.
- right UOQ breast lump (present complain) pathologically proved outside baheya DCIS.

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO views
- IV low osmolar non-ionic contrast medium infusion 100 ml

REPORT:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed mild symmetrical back ground parenchymal enhancement.
- Right UOQ mass with newly developed calcifications in 2D views) showing Avid heterogenous mass enhancement measured (2.8 x 1.7 cm) 2.9 cm from nipple nad by complementary ultrasound ill defined hypoechoic with angular margin and with calcifications measuring about (3.1 x 1.3 cm) (0.8 cm) away from the skin with anterior dilated duct with avascular echogenic content reaching to the nipple measuring about (1.9 cm) ?? Ductal extension.
- Right para areolar previous operative bed showing linear hypoechoic scar with no underlying suspicious lesions.
- Right prominent lymph node with preserved fatty hilum and cortical thickness (1.9 mm).
- No left Breast mass or non mass enhancement.
- Left UOQ lumpectomy scar showing linear hypoechoic scar with no underlying solid or cystic lesions.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Left non specific axillary lymph node.
- Free infraclavicular and supraclavicular regions on both sides.

OPINION:

- right UOQ newly developed breast mass with suspicious enhancement

PATIENT: Manal Gomaa Ibrahim Awad, 2019073644, Female, 49 y

Report version 1, 29-Apr-2026 11:59 AM

Page 1 of 2



www.Baheya.org



16602

مركز بهية الهرم
4 شارع عليّة نول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة

مستشفى بهية الشيخ زايد
4 الجيزة الأولى - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة



[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name	: الأستاذ / منال جمعه ابراهيم عواد	Request No.	: 13005681
Patient No.	: 27610052103007	Request Date	: 02/04/2026
Path No.	: 860/26	Verification Date	: 11/04/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 49 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right breast UOQ suspicious lesion (BIRADs 4c) in patient underwent right CBS for malignant lesion and left lumpectomy for benign lesion 2 years ago.

Nature Of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 1/04/2026, at 14:00 pm, cold ischemia time: 20 seconds.

Gross examination:

Fragmented grey white tissue cores ranging in size from 0.3 cm to 1.5 cm long, totally submitted.

Microscopic examination

* Histological type: High grade ductal carcinoma insitu.

* Microcalcification: Present.

* No invasive component in submitted cores.

Diagnosis

Right UOQ breast lesion, Tru-cut biopsy:

High grade ductal carcinoma insitu. No invasive component within submitted material.

For further immunophenotyping (ER, CALPONIN & P63).

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed



NAME: manal gomaa

DATE;4/5/2026

Trans-vaginal ultrasound scanning revealed: -

○ **Uterus: -**

- *AVF, average size uterus measuring about: 7x4x3cm in its longitudinal, transverse & AP diameters respectively.*
- *The myometrium shows homogenous texture with no focal lesion*
- *The endometrial line is 4mm.*
- *The cervix is of average size with no focal lesion*

○ **Ovaries: -**

- *Both ovaries are average size with no focal lesion*
- *No gross adnexal soft tissue masses or cysts.*
- *No free fluid in the Douglas pouch.*

Conclusion:

Unremarkable study

Best regards
Dr. NERMEEN RAMADAN FEBR, MD

Patient's Name: manal gomaa ebrahem awad
Date: 2026-04-18
Referred by: Prof.Dr. ct chest
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**MULTISLICE CT EXAMINATION OF THE CHEST WITHOUT
CONTRAST REVEALED:-**

Known case of CA breast.

- Right breast heterogenous parenchyma and calcific focus for sono-mammography.
- Clear both lungs showing no pulmonary nodules, masses, consolidation, collapse or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial effusion.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- Intact bony thoracic cage.

Opinion:-

❖ No pulmonary metastatic lesions.

Dr.sherif Wagdy

Dr.sherif Wagdy

Patient's Name: Manal Jumaa Ibrahim Awad
Date: 2026-06-03
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

Known case of breast CA underwent right BCS.

I- CHEST:

- Right breast lesion is seen measuring 25 x 14 mm with adjacent metallic marker for sono-mammography.
- Right upper lobe subpleural reticulations likely post radiation sequelae.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing diffuse low parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

Opinion:

❖ No pulmonary or hepatic metastatic lesions.

Dr.sherif Wagdy

Patient Name	مائل جيمه ابراهيم	Case No.	373379
Sex/Age	Female 49 Y	Patient No.	25172
Registered Date	08/9/2026 03:57:50 PM	Referred By Dr.	Surgery
Validation Date	17/9/2026 10:23:57 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	26/9/2026 12:09:33 PM	Pathology No.	2339/26

Biomarker report

Clinical Data: Right breast mass.

Nature of Specimen: Right simple mastectomy.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:

- * IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: No nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- PR: No nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67: 35%.

Conclusion:

Right breast mass:

Mixed metaplastic squamous carcinoma & invasive breast carcinoma, NST (80%).

IPT:

- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: High (score 3+).
- Ki67%: 35%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within >

